UNIÃO METROPOLITANA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (UNIME)

CURSO DE ODONTOLOGIA

Disciplina: Atenção Odontológica nos Ciclos de Vida – Bebês, Crianças e Adolescentes

Professora: Grazielle Marçal Barbosa

Caroline Jesus Santos

Fernanda Bispo

CARTILHA DE CONSULTA RÁPIDA EM TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA EM ODONTOPEDIATRIA

Analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, anestésicos locais, cálculos de dose e casos clínicos

Lauro de Freitas

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....3
1.1 Objetivos.....3
2 ANALGÉSICOS E ANTI-INFLAMATÓRIOS.....3
2.1 Analgésicos.....3
2.2 Anti-inflamatórios.....4
3 ANTIBIÓTICOS E PROFILAXIA ANTIBIÓTICA.....5
3.1 Antibioticoterapia terapêutica.....5
3.2 Profilaxia antibiótica.....5
4 ANESTÉSICOS LOCAIS E VASOCONSTRITORES.....6
4.1 Farmacologia e segurança.....6
4.2 Método de cálculo anestésico.....7
5 CÁLCULO DE DOSES MEDICAMENTOSAS.....7
6 ANTISSÉPTICOS, TÓPICOS, ANTIFÚNGICOS E ANTIVIRAIS.....8
7 PRESCRIÇÃO RACIONAL E SEGURANÇA MEDICAMENTOSA.....8
8 CASOS CLÍNICOS.....9
8.1 Caso clínico 1 – Manejo da dor odontológica.....9
8.2 Caso clínico 2 – Infecção odontogênica.....10
8.3 Caso clínico 3 – Anestesia local em Odontopediatria.....10
9 CONCLUSÃO.....11
REFERÊNCIAS.....11

1 INTRODUÇÃO

A terapêutica medicamentosa em Odontopediatria exige raciocínio distinto do aplicado ao adulto: a criança não é um “adulto em miniatura” e as variações de peso, a maturação hepática e renal e a menor margem de segurança fazem com que erros de dose, antes toleráveis, tornem-se graves. A prescrição segura começa em um diagnóstico adequado, pois o fármaco é sempre adjuvante ao tratamento da causa (pulpotomia, pulpectomia, exodontia, drenagem) e nunca seu substituto (AAPD, 2024; ANDRADE, 2014).

Esta cartilha de consulta rápida reúne informações sobre analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, anestésicos locais, antissépticos, antifúngicos e antivirais, com quadros comparativos, cálculos demonstrados em todas as etapas e três casos clínicos. As doses foram conferidas na *Reference Manual of Pediatric Dentistry* da American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD, 2024), em Malamed (2020), na declaração da American Heart Association (WILSON et al., 2021) e nas bulas do Bulário Eletrônico da Anvisa (BRASIL, s.d.); as divergências entre fontes são sinalizadas e discutidas. As doses são referências de consulta: não dispensam o julgamento clínico nem a conferência da bula vigente.

1.1 Objetivos

Objetivo geral: sistematizar os fundamentos da terapêutica medicamentosa em Odontopediatria, de modo a apoiar uma prescrição racional, segura e individualizada.

Objetivos específicos: (a) comparar os principais fármacos quanto a indicações, contraindicações, efeitos adversos e doses por administração e diária; (b) demonstrar os cálculos anestésicos e de doses em mg/kg e mL; (c) distinguir profilaxia de tratamento antibiótico; e (d) aplicar o conteúdo em três casos clínicos.

2 ANALGÉSICOS E ANTI-INFLAMATÓRIOS

2.1 Analgésicos

O manejo da dor inicia-se pela remoção da causa e pela avaliação da intensidade da dor, da presença de inflamação, febre e comorbidades. Na dor aguda moderada, a analgesia deve ser prescrita em horários fixos, por 24 a 72 horas, e não apenas “se dor”, pois isso reduz picos álgicos (AAPD, 2024). Para dor leve a moderada sem inflamação, indicam-se paracetamol ou dipirona; havendo componente inflamatório (pulpite, pós-operatório de exodontias), o ibuprofeno tende a ser mais eficaz. Opioides como codeína e tramadol são contraindicados em menores de 12 anos pelo risco de depressão respiratória, e a nimesulida é contraindicada em menores de 12 anos no Brasil (BRASIL, s.d.).

Quadro 1 – Analgésicos e AINEs: indicação, dose por administração, dose diária máxima e cuidados

Fármaco	Mecanismo / indicação	Dose por administração	Intervalo	Dose diária máxima	Contraindicações / precauções
Paracetamol	Inibição central da COX; dor leve a moderada e febre	10–15 mg/kg	4–6 h	75 mg/kg/dia (máx. 4 g/dia)	Hepatopatia, hipersensibilidade. Hepatotóxico em superdose; atenção a associações e "antigripais" com paracetamol.
Dipirona	Inibição da COX e ação espasmolítica; dor e febre	10–25 mg/kg	6 h	Até 4 doses/dia (máx. 4 g/dia)	Menores de 3 meses ou 5 kg; discrasias sanguíneas, deficiência de G6PD, porfiria. Agranulocitose rara; hipotensão se administração rápida.
Ibuprofeno	Inibição de COX-1 e COX-2; dor inflamatória e pós-operatória	5–10 mg/kg	6–8 h	40 mg/kg/dia	Menores de 6 meses; úlcera, doença renal, asma sensível a AINE, desidratação, suspeita de dengue ou varicela. Tomar com alimento.
Codeína, tramadol, nimesulida	—	Não utilizar	—	—	Contraindicados em menores de 12 anos (BRASIL, s.d.).

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em AAPD (2024) e BRASIL (s.d.).

2.2 Anti-inflamatórios

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) inibem a ciclo-oxigenase e reduzem a síntese de prostaglandinas, com ação analgésica, antitérmica e anti-inflamatória. Os corticosteroides atuam em etapa anterior da cascata inflamatória e na expressão de citocinas, com efeito mais amplo e imunossupressor. Em Odontopediatria, o AINE por curto prazo é a escolha na grande maioria dos casos; o corticosteroide fica reservado a edema ou trismo importantes e a reações alérgicas, em ciclos curtos e após excluir infecção ativa não controlada (Quadro 2).

Quadro 2 – Comparação entre AINEs e corticosteroides em crianças

Aspecto	AINEs (ex.: ibuprofeno)	Corticosteroides (ex.: prednisolona)
Mecanismo	Inibição de COX-1/COX-2 e redução de prostaglandinas	Inibição da fosfolipase A2 e da transcrição de citocinas; imunossupressão
Indicação	Dor inflamatória, pós-operatório, febre	Edema/trismo importantes, trauma extenso, reações alérgicas
Dose usual	Ibuprofeno 5–10 mg/kg a cada 6–8 h (máx. 40 mg/kg/dia)	Prednisolona 0,5–2 mg/kg/dia (usual 1 mg/kg), dose única matinal, 3 a 5 dias. Outros corticoides: conferir equivalência e bula.
Efeitos adversos	Gastrite, nefrotoxicidade, broncoespasmo, aumento do sangramento	Hiperglicemia, alteração de humor, imunossupressão, atraso de cicatrização; supressão adrenal em uso prolongado
Precauções	Asma sensível a AINE, úlcera, doença renal, desidratação, dengue; não associar dois AINEs	Infecção sistêmica não controlada, varicela e herpes ativos; evitar associar a AINE (risco gástrico)
Uso racional	Menor dose eficaz, menor tempo, boa hidratação	Somente com benefício claro; não repetir ciclos sem reavaliação

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em AAPD (2024), ANDRADE (2014) e BRASIL (s.d.).

3 ANTIBIÓTICOS E PROFILAXIA ANTIBIÓTICA

3.1 Antibioticoterapia terapêutica

A maioria das infecções odontogênicas é polimicrobiana, com predomínio de estreptococos e anaeróbios, e é controlada pela remoção da fonte (pulpectomia, exodontia, drenagem). **Não há indicação de antibiótico** em pulpite, abscesso localizado e drenado, fístula ativa sem sinais sistêmicos, dor sem infecção ou alveolite. **Há indicação** quando existem sinais de disseminação (celulite, edema facial difuso, linfadenopatia), febre, mal-estar, impossibilidade de drenagem local ou imunossupressão, sempre associada ao tratamento odontológico (AAPD, 2024). A escolha considera o diagnóstico, a gravidade, a alergia a penicilinas e as condições sistêmicas; a amoxicilina é a primeira opção, e o tratamento deve ser curto (em geral 5 a 7 dias), com reavaliação em 48 a 72 horas. O uso desnecessário ou prolongado seleciona bactérias resistentes e causa diarreia e candidíase, por isso a falha terapêutica deve levar à reavaliação da causa, e não à troca automática por antibiótico de maior espectro.

Quadro 3 – Antibióticos usados em Odontopediatria: doses diárias e fracionamento

Fármaco	Indicação	Dose diária	Fracionamento / duração	Observações
Amoxicilina	1ª escolha em infecções odontogênicas	25–50 mg/kg/dia	8/8 h (ou 12/12 h); 5–7 dias	Não exceder dose adulta (500 mg/dose). Alergia a penicilinas é contraindicação.
Amoxicilina + clavulanato	Falha à amoxicilina; infecções mais extensas	25–50 mg/kg/dia (componente amoxicilina)	8/8 h ou 12/12 h (conforme formulação); 5–7 dias	Diarreia frequente; tomar com alimento.
Penicilina V	Alternativa para infecções leves	25–50 mg/kg/dia	6/6 h; 5–7 dias	Posologia pouco prática, pior adesão.
Clindamicina	Alergia a penicilinas	10–25 mg/kg/dia	6/6 ou 8/8 h; 5–7 dias	Risco de colite pseudomembranosa: suspender se diarreia intensa.
Azitromicina	Alternativa em alérgicos	10 mg/kg no 1º dia (máx. 500 mg) e 5 mg/kg/dia nos dias 2–5 (máx. 250 mg)	1×/dia; 5 dias	A bula costuma indicar 10 mg/kg/dia por 3 dias (divergência). Risco de prolongamento do QT e interações.
Metronidazol	Associado a β-lactâmico para anaeróbios	15–30 mg/kg/dia	8/8 h	Nunca isolado em infecção odontogênica; sabor metálico.

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em AAPD (2024) e BRASIL (s.d.).

3.2 Profilaxia antibiótica

A profilaxia é **dose única, pré-procedimento**, destinada a prevenir endocardite infecciosa em pacientes de risco muito elevado, e difere do tratamento de uma infecção já estabelecida, que exige esquema de vários dias. Segundo a AHA (WILSON et al., 2021),

considera-se profilaxia em: válvula cardíaca protética ou material protético em reparo valvar; endocardite prévia; cardiopatia congênita cianótica não corrigida ou paliativa; cardiopatia corrigida com material protético (nos primeiros 6 meses, ou permanentemente se houver defeito residual); e transplante cardíaco com valvulopatia. Aplica-se apenas a procedimentos com manipulação gengival, da região periapical ou perfuração da mucosa (exodontias, raspagem, pulpectomia com ultrapassagem apical). **Não está indicada** para anestesia por injeção em tecido sadio, radiografias, colocação de aparelhos ortodônticos removíveis, esfoliação de dentes decíduos ou trauma de lábio e mucosa. A avaliação é individualizada e, em dúvida, deve-se consultar o cardiologista.

Quadro 4 – Regimes de profilaxia da endocardite infecciosa, dose única 30–60 min antes do procedimento

Situação	Fármaco	Dose pediátrica (via oral, salvo indicação)
Padrão	Amoxicilina	50 mg/kg (máx. 2 g)
Impossibilidade de via oral	Ampicilina, cefazolina ou ceftriaxona	50 mg/kg IM ou IV (máx. 1–2 g)
Alergia a penicilinas	Cefalexina (se não houve anafilaxia, angioedema ou urticária)	50 mg/kg (máx. 2 g)
Alergia a penicilinas	Azitromicina ou claritromicina	15 mg/kg (máx. 500 mg)
Alergia a penicilinas	Doxiciclina	2,2 mg/kg (máx. 100 mg)

Fonte: adaptado de WILSON et al. (2021). Nota: a clindamicina deixou de ser recomendada na AHA (2021) pelo risco de colite.

4 ANESTÉSICOS LOCAIS E VASOCONSTRITORES

4.1 Farmacologia e segurança

Os anestésicos locais bloqueiam os canais de sódio voltagem-dependentes, impedindo a condução do impulso nervoso. Os vasoconstritores (epinefrina, felipressina) prolongam e aprofundam a anestesia, reduzem o sangramento e diminuem a absorção sistêmica, o que reduz a toxicidade. Devem ser usados com cautela em cardiopatias, hipertireoidismo e uso de certos medicamentos; nesses casos, limita-se a epinefrina ou opta-se por anestésico sem vasoconstritor ou com felipressina (MALAMED, 2020). A lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 é o padrão em crianças; a articaína 4% é efetiva, mas a bula não a recomenda em menores de 4 anos; a bupivacaína não é recomendada pela longa duração, que aumenta o risco de mordedura de lábio e língua.

A toxicidade sistêmica está ligada ao peso, e a dose máxima cai rapidamente em crianças pequenas: em 10 kg, a lidocaína 2% permite apenas 44 mg, ou seja, pouco mais de um tubete. Os sinais precoces são zumbido, gosto metálico, agitação e fala arrastada, seguidos de convulsão e depressão cardiorrespiratória. Para prevenir: calcular a dose pelo peso real, aspirar antes de injetar, injetar lentamente (cerca de 1 mL/min), usar técnica infiltrativa

sempre que possível (osso menos denso) e somar o anestésico tópico à dose total. Os responsáveis devem ser orientados sobre a anestesia prolongada, para evitar mordiscar lábio, língua e bochecha.

Quadro 5 – Anestésicos locais em tubetes de 1,8 mL: concentração, dose máxima e observações

Anestésico	Conc. (mg/mL)	mg por tubete	Dose máx. (mg/kg)	Máximo absoluto	Observações pediátricas
Lidocaína 2% + epinefrina 1:100.000	20	36	4,4	300 mg	Padrão em crianças; anestesia pulpar de cerca de 60 min.
Mepivacaína 3% (sem vasoconstritor)	30	54	4,4 (AAPD) ou 6,6 (Malamed)	300 mg (AAPD) ou 400 mg	Útil quando se evita vasoconstritor; ação curta. Divergência entre fontes.
Articaína 4% + epinefrina 1:100.000	40	72	7	500 mg	Bula: não recomendada abaixo de 4 anos; boa difusão óssea.
Prilocaína 3% + felipressina 0,03 UI/mL	30	54	6	400 mg	Alternativa em cardiopatas; risco de metemoglobinemia.
Bupivacaína 0,5% + epinefrina 1:200.000	5	9	1,3	90 mg	Não recomendada em crianças.

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em MALAMED (2020), AAPD (2024) e BRASIL (s.d.).

4.2 Método de cálculo anestésico

O cálculo segue cinco etapas: (1) converter a concentração percentual em mg/mL, multiplicando a porcentagem por 10 (1% = 10 mg/mL); (2) obter os mg por tubete = mg/mL × volume do tubete (1,8 mL); (3) calcular a dose máxima = mg/kg × peso (kg), respeitando o máximo absoluto; (4) obter o número máximo teórico de tubetes = dose máxima ÷ mg por tubete; (5) repetir o cálculo para o vasoconstritor (1:100.000 = 0,01 mg/mL = 0,018 mg por tubete), cujo limite é 0,2 mg em paciente saudável e 0,04 mg em cardiopatas ASA III–IV (MALAMED, 2020). O menor valor entre os fármacos define o limite. Como o resultado é teórico, adota-se margem de segurança: arredonda-se para baixo e planeja-se usar apenas a fração necessária, mantendo reserva para reforço. A aplicação está no Caso Clínico 3.

5 CÁLCULO DE DOSES MEDICAMENTOSAS

A dose **por administração** (mg/kg/dose) é aplicada a cada tomada; a dose **diária total** (mg/kg/dia) é dividida pelo número de tomadas. Confundir as duas é causa frequente de erro: amoxicilina 50 mg/kg/dia significa 16,7 mg/kg a cada 8 horas, e não 50 mg/kg por tomada. A conversão para volume usa a concentração do frasco: mg/mL = mg do frasco ÷ mL do frasco (ex.: 250 mg/5 mL = 50 mg/mL), e volume (mL) = dose (mg) ÷ concentração (mg/mL). É essencial confirmar a apresentação comercial, pois a mesma substância existe em concentrações diferentes (amoxicilina 250 mg/5 mL e 500 mg/5 mL), e a troca dobra a dose.

Exemplo – Identificação de erro de prescrição (criança de 15 kg)
Prescrição recebida: paracetamol 200 mg/mL, 3 mL por via oral de 4/4 h.
1) Dose por tomada: 3 mL × 200 mg/mL = 600 mg → 600 mg ÷ 15 kg = **40 mg/kg/dose** (limite 10–15 mg/kg).
2) Dose diária: 24 h ÷ 4 h = 6 tomadas × 600 mg = 3.600 mg → 3.600 ÷ 15 = **240 mg/kg/dia** (limite 75 mg/kg/dia = 1.125 mg).
3) Interpretação: a dose é ≈ 3 vezes a máxima por tomada e ≈ 3 vezes a diária, com risco de hepatotoxicidade. Prescrição incorreta.
4) Correção: 12,5 mg/kg × 15 kg = 187,5 mg → 187,5 ÷ 200 = 0,94 mL ≈ **0,9 mL a cada 6 h** (máx. 4 doses = 750 mg/dia = 50 mg/kg/dia, dentro do limite).

Outros erros a rastrear: associação de dipirona e paracetamol com antigripal que também contém paracetamol (duplicidade de princípio ativo); dois AINEs (ibuprofeno e diclofenaco); confusão entre gotas e mL; uso de colher doméstica em vez de seringa dosadora; e doses superiores às de adulto. A prescrição deve conter nome genérico, concentração, dose em mg e em mL, via, intervalo e duração, escritos de forma legível.

6 ANTISSÉPTICOS, TÓPICOS, ANTIFÚNGICOS E ANTIVIRAIS

Quadro 6 – Antissépticos, anestésicos tópicos, antifúngicos e antivirais de uso odontopediátrico

Agente	Indicação	Posologia / apresentação	Limitações e cuidados
Clorexidina 0,12% (bochecho)	Redução do biofilme em período limitado, pós-cirúrgico	Bochecho de 10–15 mL, 2×/dia, em crianças que cospem (em geral > 6 anos)	Pigmentação dentária, alteração do paladar; não deglutir; uso curto.
Clorexidina 2%	Limpeza de cavidade, irrigação e antissepsia local	Aplicação tópica	Alergia (rara); não usar em contato com olhos e ouvido médio.
Hipoclorito de sódio 0,5–2,5%	Irrigação endodôntica (pulpectomia de decíduos)	Irrigação com isolamento e seringa sem pressão	Irritante; risco de extrusão periapical; proteger a pele e os olhos.
Povidona-iodo 10%	Antissepsia perioral e extrabucal	Aplicação tópica	Alergia a iodo, disfunção tireoidiana e recém-nascidos.
Benzocaína 20% / lidocaína tópica	Anestesia de mucosa antes da punção	Quantidade mínima, em área seca	Metemoglobinemia (benzocaína; prilocaína em EMLA®); evitar em < 2 anos; somar à dose total de lidocaína.
Nistatina 100.000 UI/mL	Candidíase pseudomembranosa	1 mL (lactentes) até 4–6 mL (crianças maiores), 4×/dia, mantendo em contato com a mucosa; 7–14 dias e 48 h após a remissão	Sem absorção sistêmica relevante; higienizar chupetas e próteses. Conferir bula.
Miconazol gel oral 2%	Candidíase oral	Aplicação na lesão, 4×/dia	Risco de engasgo em lactentes; interage com varfarina.
Fluconazol	Candidíase refratária ou em imunossuprimidos	6 mg/kg no 1º dia e 3 mg/kg/dia por 7–14 dias	Hepatotoxicidade; interação com midazolam (aumenta a sedação).
Aciclovir	Gengivoestomatite herpética primária (iniciar em até 72 h); herpes labial	VO: 15 mg/kg/dose, 5×/dia por 7 dias, ou conforme a bula por faixa etária (100–200 mg 5×/dia); creme 5%, 5×/dia por 4–5 dias	Hidratar; ajustar em insuficiência renal. Analgesia e hidratação são a base do tratamento.

Fonte: elaborado pelas autoras, com base em AAPD (2024), ANDRADE (2014) e BRASIL (s.d.).

7 PRESCRIÇÃO RACIONAL E SEGURANÇA MEDICAMENTOSA

A prescrição racional exige avaliação individualizada: peso atual, idade, alergias, comorbidades (cardiopatias, asma, hepatopatias, nefropatias, imunossupressão) e

medicamentos em uso. Devem-se checar interações e duplicidades, por exemplo ibuprofeno com anticoagulantes, macrolídeos com fármacos que prolongam o QT, fluconazol com midazolam e uso simultâneo de vários produtos com paracetamol. O ácido acetilsalicílico deve ser evitado em crianças com quadros virais pelo risco de síndrome de Reye. Os responsáveis devem receber orientação escrita sobre dose em mL, horários, duração, sinais de alerta e armazenamento fora do alcance de crianças, com uso de seringa dosadora. Convém orientar:

a) não repetir doses por conta própria nem combinar produtos sem orientação, para evitar intoxicações;
b) completar o antibiótico pelo tempo prescrito e descartar sobras na farmácia;
c) retornar imediatamente diante de sinais de gravidade.

Sinais de gravidade que exigem urgência ou encaminhamento hospitalar: dificuldade para respirar ou engolir, trismo, salivação excessiva, edema de assoalho bucal, pescoço ou região periorbitária, febre alta persistente, prostração, desidratação, rápida progressão do edema, alteração do estado de consciência, reação alérgica sistêmica e infecção em criança imunossuprimida (AAPD, 2024).

8 CASOS CLÍNICOS

8.1 Caso clínico 1 – Manejo da dor odontológica

Paciente de 7 anos, 24 kg, ASA I, sem alergias, asma ou uso de medicamentos, com dor espontânea, pulsátil e noturna há dois dias no dente 85 (cárie profunda; escala visual analógica 7/10). Não há edema, fístula ou febre. Os responsáveis relatam uso associado de dipirona e paracetamol em casa, com pouco alívio.

Avaliação e conduta. O quadro é compatível com pulpite irreversível sintomática, e a conduta é a pulpectomia (ou exodontia, se o dente for irrecuperável), sob anestesia local, na mesma sessão. A analgesia é necessária para controlar a dor residual. Como a dor tem componente inflamatório e não há contraindicação (asma, úlcera, doença renal, desidratação ou suspeita de dengue), o ibuprofeno é a escolha, com paracetamol como alternativa. Orienta-se suspender a associação de dipirona e paracetamol, pois são fármacos de mesma finalidade, sem benefício comprovado e com risco de duplicidade (AAPD, 2024).

Cálculo – Ibuprofeno 50 mg/mL (gotas) e alternativa com paracetamol 200 mg/mL
1) Dose escolhida: 7,5 mg/kg/dose (faixa 5–10 mg/kg) × 24 kg = **180 mg por dose**.
2) Volume: 180 mg ÷ 50 mg/mL = **3,6 mL por dose**, a cada 8 h (usar seringa dosadora; converter em gotas conforme o frasco).
3) Dose diária: 3 doses × 180 mg = 540 mg/dia = 22,5 mg/kg/dia (limite 40 mg/kg/dia = 960 mg). Seguro.
4) Alternativa: paracetamol 12,5 mg/kg × 24 kg = 300 mg → 300 ÷ 200 = **1,5 mL a cada 6 h** (4 doses = 1.200 mg/dia = 50 mg/kg/dia; limite 75 mg/kg/dia = 1.800 mg).
5) Interpretação: prescrever por 48–72 h em horários fixos; reavaliar se a dor persistir, o que sugere falha do tratamento da causa.

8.2 Caso clínico 2 – Infecção odontogênica

Criança de 5 anos, 18 kg, sem alergias, com edema vestibular localizado, flutuante, adjacente ao dente 75 com necrose pulpar. Está afebril, alimenta-se normalmente e tem abertura bucal preservada.

Cenário A – infecção localizada. O tratamento é local: drenagem pelo canal ou por incisão e pulpectomia ou exodontia do dente 75. **Não há indicação de antibiótico**, pois não existem sinais sistêmicos e a drenagem é possível (AAPD, 2024). Prescreve-se analgesia e programa-se retorno em 48 a 72 horas.

Cenário B – disseminação. Se a criança apresentar febre de 38,8 °C, edema facial difuso, linfadenopatia e mal-estar, mas mantiver respiração, deglutição e abertura bucal normais, associa-se **amoxicilina** à intervenção local no mesmo dia, com reavaliação em 48 a 72 horas. Em alergia a penicilinas, usa-se clindamicina.

Cenário C – gravidade. Dificuldade respiratória ou de deglutição, trismo, edema de assoalho bucal, pescoço ou região periorbitária, desidratação, prostração ou rápida progressão exigem **encaminhamento hospitalar imediato** para antibioticoterapia intravenosa, drenagem e monitorização, sem aguardar resposta ao antibiótico oral.

Cálculo – Cenário B (18 kg)
1) Amoxicilina 50 mg/kg/dia × 18 kg = 900 mg/dia → ÷ 3 tomadas = **300 mg por dose** (menor que a dose adulta de 500 mg).
2) Suspensão 250 mg/5 mL = 50 mg/mL → 300 mg ÷ 50 mg/mL = **6 mL a cada 8 h, por 7 dias** (21 doses = 126 mL no total).
3) Se alergia a penicilinas: clindamicina 20 mg/kg/dia × 18 kg = 360 mg/dia → ÷ 3 = 120 mg por dose; solução 75 mg/5 mL = 15 mg/mL → 120 ÷ 15 = **8 mL a cada 8 h** (dentro da faixa de 10–25 mg/kg/dia).
4) Interpretação: dose diária dentro da faixa pediátrica; orientar sobre diarreia, adesão e retorno se não houver melhora em 48–72 h.

8.3 Caso clínico 3 – Anestesia local em Odontopediatria

Criança de 6 anos, 18 kg, ASA I, para pulpotomia dos dentes 74 e 75, com **lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000** em tubetes de 1,8 mL.

Cálculo – Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000 (18 kg)
1) Concentração: 2% = 2 g/100 mL = 2.000 mg/100 mL = **20 mg/mL**.
2) Por tubete: 20 mg/mL × 1,8 mL = **36 mg**.
3) Dose máxima: 4,4 mg/kg × 18 kg = **79,2 mg** (inferior ao máximo absoluto de 300 mg).
4) Tubetes: 79,2 mg ÷ 36 mg/tubete = **2,2 tubetes**.
5) Epinefrina 1:100.000 = 1 g/100.000 mL = 0,01 mg/mL × 1,8 mL = **0,018 mg/tubete**. Paciente saudável (limite 0,2 mg): 0,2 ÷ 0,018 = 11,1 tubetes. Cardiopata ASA III (limite 0,04 mg): 0,04 ÷ 0,018 = 2,2 tubetes.
6) Limite determinante: a **lidocaína** (2,2 tubetes). Margem de segurança: no máximo 2 tubetes (72 mg = 4,0 mg/kg, 91% da dose máxima); o plano clínico é de 1 a 1,5 tubete (36–54 mg = 2–3 mg/kg, 45–68% do limite), reservando o restante para reforço.

Interpretação e condições clínicas. No paciente saudável o fator limitante é a lidocaína, e não a epinefrina, e a dose real necessária para pulpotomia é bem inferior ao limite. Se fosse cardiopata, o limite de epinefrina (0,04 mg) coincidiria com o da lidocaína, exigindo aspiração, injeção lenta e discussão com o cardiologista; uma alternativa seria a mepivacaína 3% sem vasoconstritor (54 mg/tubete). Com 4,4 mg/kg (AAPD), o limite seria 79,2 mg ÷ 54 mg = 1,47 tubete; com 6,6 mg/kg (Malamed), 118,8 mg ÷ 54 mg = 2,2 tubetes. Diante da divergência, adota-se o valor mais conservador. Qualquer anestésico tópico deve ser descontado da dose total, e os responsáveis devem ser orientados a evitar mordiscamento dos tecidos anestesiados.

9 CONCLUSÃO

A terapêutica medicamentosa em Odontopediatria deve ser guiada por princípios: (a) diagnosticar e tratar a causa, pois o fármaco é adjuvante; (b) indicar antibiótico apenas diante de sinais de disseminação, febre ou impossibilidade de drenagem, reservando a profilaxia a condições cardíacas de alto risco; (c) calcular toda dose pelo peso, distinguindo mg/kg/dose de mg/kg/dia e conferindo a concentração da apresentação; (d) respeitar limites anestésicos e do vasoconstritor, com margem de segurança; (e) evitar duplicidades, interações e fármacos contraindicados na infância; (f) orientar os responsáveis e reconhecer sinais de gravidade. Assim, a prescrição torna-se um ato clínico individualizado, seguro e fundamentado em evidências.

REFERÊNCIAS

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY (AAPD). **The reference manual of pediatric dentistry**. Chicago: AAPD, 2024. (Inclui as diretrizes *Use of local anesthesia for pediatric dental patients*, *Pain management in infants, children, adolescents, and individuals with special health care needs* e *Use of antibiotic therapy for pediatric dental patients*.) Disponível em: https://www.aapd.org/. Acesso em: 10 nov. 2026.

ANDRADE, Eduardo Dias de. **Terapêutica medicamentosa em odontologia**. 3. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2014.

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). **Bulário Eletrônico**. Brasília, DF: Anvisa, [s.d.]. Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/. Acesso em: 10 nov. 2026.

MALAMED, Stanley F. **Handbook of local anesthesia**. 7. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.

WILSON, Walter R. et al. Prevention of viridans group streptococcal infective endocarditis: a scientific statement from the American Heart Association. **Circulation**, Dallas, v. 143, n. 20, p. e963–e978, 2021.